

MARCOLINO DOS ANJOS PIRES TAVARES

MEDICO:

MEDICAMENTOS:

IMC

CIRCUNF. DE PESCOÇO

PA:

OXIMETRIA:

26/02 P = 8.2 — ↑ 90 cmH₂O

22 Fuga = 20.6

22 IAH = 5.0

feia

02/02 pte bem adaptado, porém q escape de ar pela boca. Orientei sobre o espadrapo. — feia
22 ± comprou CPAP.

19/02 P = 9.4 cmH₂O

22 IAH = 3.5

M. de uso: 8h

Fuga: 27.

Bem adaptado

feia

25/03 P = 9.4 cmH₂O

22 IAH = 2.9

M. de uso: 8h

Filtro OK

feia

24/06 P = 9.4 cmH₂O

22 IAH = 2.5/h

M. de uso: 7h 34'

24/03 P = 9.4 cmH₂O

22 M. de uso: 7h 31'

IAH = 2.7

TROCO O FILTRO

feia

24/11 P = 9.4 cmH₂O

22 IAH = 2.4 elev

M. de uso: 7h 45'

Fuga = 26, 2 l/min

Relato obstr. nasal durante o dia

feia

26/01 P = 9.4 cmH₂O
23 IAH = 1.4 e/h
m. de uso: 8h
Fuga = 14.2 l/min.

Bem adaptado
coloco um obs. p/ br.
maria forge sua

27/03 P = 9.4 cmH₂O
2023 IAH = 1.5 e/h
m. de uso: 7h45
fuga: 16 l/min

bem adaptado
vai viajar mais / quanto levar

31/05 P = 9.4 cmH₂O
23 m. de uso: 7h33
IAH = 1.6 e/h

s/ sintomas
relata estar resp. pela boca
sua

23/08 P = 9.4 cmH₂O
IAH = 1.6 l/min
m. de uso: 7h40

Ana

23/11 P = 9.4 cmH₂O
23 IAH = 2.7 e/h
m. de uso: 7h15
Fuga = 26.7 l/min.

Bem adaptado

sua

23/01 P = 9.4 cmH₂O
24 IAH = 2.5 e/h
m. de uso: 7h23
Fuga = 0.0

Bem adaptado, sem queixas
dos sintomas
sua

23/04 P = 9.4 cmH₂O
24 IAH = 2.5 e/h
m. de uso: 7h27m
fuga: 0.4 l/min

Bem adaptado, sem queixas
Natacha

24/07 P = 9.4 cmH₂O
24 IAH = 3.1 e/h
m. de uso: 7h24
fuga: 29.2 l/min

Bem adaptado
Natacha

23/10 P = 9.4 cmH₂O
24 IAH = 2.5 e/h
m. de uso: 7h

* troco filtro + finador
Bem adaptado, e/↑ do escape
de ar.

d. n. Claudio

11 P = 9.4 cmH₂O
4 IAH = 1.7 e/h
m. de uso: 8h32
fuga: 20 l/min

1/01 30 d uso
25 m. de uso
P = 9.4
IAH = 2

2/05/25 P = 9.4
IAH =
m. de uso
fuga

06/11 $P = 9,4 \text{ cmH}_2\text{O}$

2024 $IAH = 1,7 \text{ e/h}$

$muro = 6h32 \text{ min}$

$fuga = 20 \text{ l/min}$

mãeellow mto apertada - mfu q falta ar

↳ ajuste (relto um pouco)

Silva

21/01 30 d uso 29 d.

25 M. de uso: 7h21

$P = 9,4 \text{ cmH}_2\text{O}$

$IAH = 2,7 \text{ e/h}$

Bem adaptado, relata
que está q cochouvo novo
em casa.

Sua.

21/05/25 $P = 9,4 \text{ cmH}_2\text{O}$

$IAH = 3,2 \text{ e/h}$

$muro = 7h40'$

$fuga = 26 \text{ l/min}$

Bem adaptado

Silva

usando almofada Mx el vazamento

↳ troco por (m).

Nome: MARCOLINO DOS ANJOS PIRES TAVARES

Data de Nascimento: 2-8-1959

IMC: 27,77

Sexo: Masculino

Data do exame: 19-10-2021

Peso: 88 kg

Altura: 1,78 m

Médico: DRA. CATHARINA SOARES DE
ANDRADE

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 19-10-2021, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO₂) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 486,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 119,0 e 231,5 minutos. O tempo total de sono foi de 236,5, eficiência de 48,7% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,4%; estágio N2: 55,8%; estágio N3: 25,4%; sono REM: 15,4%. O índice de despertares foi de 14,3/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 35,8/hora, sendo 30 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 53 hipopnéias. A SpO₂ média foi de 92% e mínima de 63%, permanecendo 10,0% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 63 - 89 bpm e NREM de 60 - 87 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (7), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem dos estágios N2 e N3 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 35,8/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO₂=63%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de atividade em EMG de queixo;
8. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (26,1/hora);
9. registro de ronco moderado durante o sono.

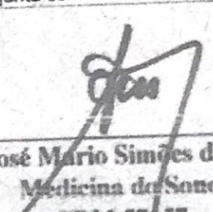
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados, associado a distúrbio de movimento.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57

Nome: MARCOLINO DOS ANJOS PIRES TAVARES

Data de Nascimento: 2-8-1959

IMC: 25,22

Sexo: Masculino

Data do exame: 24-11-2021

Peso: 79 kg

Altura: 1,77 m

Médico: DRA. CATHARINA SOARES DE
ANDRADE

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 24-11-2021, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 472,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 94,0 e 184,5 minutos. O tempo total de sono foi de 184,5, eficiência de 39,1% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,3%; estágio N2: 48,0%; estágio N3: 28,5%; sono REM: 20,3%. O índice de despertares foi de 5,1/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 8,1/hora, sendo elas 4 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 21 hipopnéias. A SpO2 média foi de 94% e a mínima de 91%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 65 - 84 bpm e NREM de 62 - 84 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (06), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM aumentada e porcentagem do estágio N2 do sono NREM normal;
3. latências para o sono prolongadas;
4. número de despertares breves normal;
5. presença de atividade em EMG de queixo;
6. aumento do número de movimentos periódicos de membros inferiores (83,9/hora);
7. registro de ronco durante o sono.

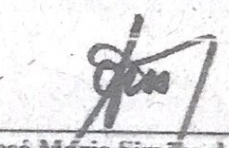
Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 6,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mário Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Dra. Catharina Soares de Andrade
Otorrinolaringologia - CRM 74.458

Marcelino dos A. P. Soares

Soluções
Adaptadas e seguras de CRM p'

Placa Alis.

(Pielomorfia do axila)

CATHARINA SOARES DE ANDRADE
Otorrinolaringologista
CRM: 74458

14/12/2011

Rua Paulo Setubal, 147 - 1º Andar - Sala 12
Vila Adyana - São José dos Campos - SP
Tel. (12) 3922-4925